



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN
KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN
PASIEN RS PRIMA HUSADA MALANG
BULAN JANUARI TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bulan April Tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilakukan berdasarkan tersedianya data, penggunaan data secara efektif dapat dilakukan secara *evidence-based* praktek klinik dan *evidence-based management*, berhubung sebagian besar rumah sakit mempunyai sumber daya terbatas, maka rumah sakit tidak dapat mengumpulkan data untuk semua hal yang diinginkan. Jadi rumah sakit memilih proses dan hasil *outcome* praktik klinik dan manajemen yang harus dinilai atau diukur dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis pelayanan. Penilaian sering terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar atau cenderung menimbulkan masalah. Pimpinan rumah sakit memiliki peranan kunci untuk memastikan rencana mutu dan keselamatan pasien membentuk budaya organisasi rumah sakit dan memberi dampak pada setiap aspek kegiatan berupa Standar Pelayanan Minimal dan pencapaiannya sesuai indikator yang dipergunakan di setiap unit pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada.

Dengan tersusunnya Laporan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bulan April tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit yang sesuai dengan STARKES. Berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikan indikator rumah sakit sebagai berikut: indikator mutu nasioanal (INM), Indikator mutu sasaran keselamatan pasien, Indikator mutu prioritas klinis rumah sakit, Indikator mutu tujuan strategis, indikator mutu perbaikan sistem, Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit).

B. Tujuan

Tujuan Umum

Mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada.

Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada melalui pemantauan indikator mutu yang telah ditetapkan pada rapat kerja akhir tahun.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu spesifik lain yang dilakukan oleh tim/ komite/ unit terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas mengenai program mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada

BAB II

KEGIATAN PEMANTAUAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT TAHUN 2026

A. Kegiatan Pokok

Kegiatan pemantauan indikator mutu pada bulan Januari tahun 2026 yang dilaporkan pada Bulan Februari Tahun 2026.

B. Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/unit
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

C. Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/unit dilakukan setiap bulan, menyusun program perbaikan mutu oleh tim peningkatan mutu rumah sakit dilaporkan pada saat rapat bulanan.
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap tiga bulan.
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu

D. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh petugas pengumpul data unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab pengumpul data. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan ke kepala instalasi/unit, hasil ditulis pada Form Supervisi dilengkapi laporan tindak lanjut program untuk indikator yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan atau setiap ditemukan suatu permasalahan di setiap instalasi kerja dan ditembuskan Sub Komite Peningkatan Mutu.

BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan capaian indikator mutu nasional RS Prima Husada Malang pada bulan Januari Tahun 2026.

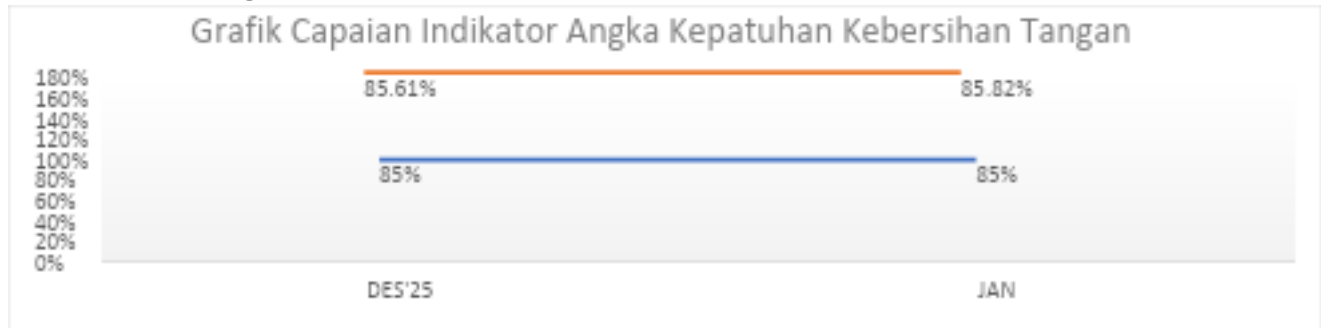
Tabel 3.1 Capaian Indikator Mutu Nasional RS Prima Husada Malang bulan Januari tahun 2026

NO	Judul Indikator	Bulan												Stan- dar	Keterangan
		Des'25	Jan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	85,61%	85.82%											≥ 85%	Ditingkatkan
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96,86%	96.82%											100%	PDSA
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	99,92%	99.96%											100%	PDSA
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	100%	100.00%											≥ 80%	Dipertahankan
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	96,91%	89.90%											≥ 80%	Dipertahankan

6.	Penundaan Operasi Elektif	0%	0.00%											≤ 5%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	67,81%	66.75%											≥ 80%	Ditingkatkan
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	100.00%											100%	Dipertahankan
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	86.13%											≥ 80%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	100%	30.51%											≥ 80%	PDSA
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	94,62%	91.54%											100%	PDSA
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100.00%											≥ 80%	Dipertahankan
13.	Kepuasan Pasien	92,80%	99.70%											≥ 76,61	Dipertahankan

3.1.1 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan RS Prima Husada Malang bulan Januari tahun 2026

Analisis:

Pada Bulan Januari, angka kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Malang mencapai 85,82%, mengalami peningkatan dibandingkan Bulan Desember Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhan petugas terhadap pelaksanaan kebersihan tangan sesuai standar prosedur. Nilai tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu $\geq 85\%$, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi program kebersihan tangan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, capaian yang masih berada dekat dengan batas minimal standar menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan petugas masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya peluang terjadinya ketidakpatuhan pada beberapa unit atau waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan seperti penguatan edukasi, monitoring rutin, pemberian umpan balik hasil observasi, serta peningkatan kesadaran petugas agar capaian kepatuhan kebersihan tangan dapat terus meningkat dan terjaga secara konsisten di atas standar yang telah ditetapkan.

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)



Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) RS Prima Husada Malang bulan Januari 2026

Analisis:

Pada Bulan Januari, angka kepatuhan penggunaan APD di RS Prima Husada Malang mencapai 96,82%, mengalami penurunan dibandingkan Bulan Desember Tahun 2025 sebesar 0,04%. Meskipun penurunan yang terjadi relatif kecil, kondisi ini menunjukkan adanya penurunan konsistensi kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri sesuai standar yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa implementasi penggunaan APD secara umum sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penerapannya di lapangan. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kurangnya kedisiplinan petugas, keterbatasan pengawasan, maupun kurang optimalnya pengingat terkait pentingnya penggunaan APD. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan melalui monitoring rutin, edukasi ulang kepada petugas, pemberian umpan balik hasil observasi, serta penguatan budaya keselamatan agar kepatuhan penggunaan APD dapat kembali meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan secara konsisten.

PLAN	Berdasarkan data indikator mutu kepatuhan penggunaan alat pelindung diri oleh petugas di atas dapat diketahui bahwa capaian belum mencapai standart. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan kedisiplinan petugas, pemahaman jenis APD belum optimal. Rencana perbaikan yang dilakukan adalah sosialisasi ulang SPO penggunaan APD, edukasi jenis APD, memastikan ketersediaan APD, meningkatkan monitoring dan supervisi.
DO	1.Melaksanakan edukasi penggunaan APD kepada seluruh petugas 2.Menyediakan APD sesuai kebutuhan dan risiko pelayanan 3. Melakukan observasi kepatuhan penggunaan APD dengan lembar audit 4. Memberikan teguran dan edukasi langsung saat ditemukan ketidakpatuhan
STUDY	Capaian indikator kepatuhan alat pelindung diri oleh petugas pada bulan Januari yaitu 96.80%. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian belum mencapai standart. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan kedisiplinan petugas, pemahaman jenis APD belum optimal. Rencana perbaikan yang dilakukan adalah sosialisasi ulang SPO penggunaan APD, edukasi jenis APD, memastikan ketersediaan APD, meningkatkan monitoring dan supervisi.

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1 Memberikan umpan balik hasil audit kepada unit terkait 2 Penguatan edukasi dan supervisi pada unit dengan kepatuhan rendah 3 Penegakan disiplin sesuai kebijakan RS 4 Menjadikan monitoring penggunaan APD sebagai kegiatan rutin dan berkelanjutan	1. Kepala ruangan dan IPCN 2. Kepala ruangan 3. Kepala Bidang	Satu Bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

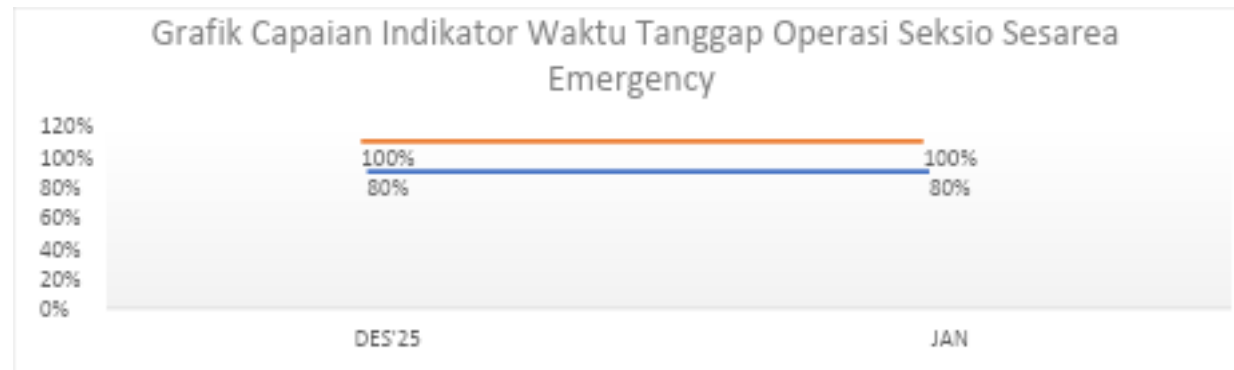
Analisis:

Pada Bulan Januari, angka kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang mencapai 96,82%, mengalami peningkatan dibandingkan Bulan Desember Tahun 2025 sebesar 0,04%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan prosedur identifikasi pasien oleh petugas sesuai standar keselamatan pasien. Capaian tersebut mencerminkan bahwa upaya penerapan budaya keselamatan pasien telah berjalan cukup baik, khususnya dalam memastikan ketepatan identifikasi sebelum pemberian tindakan maupun pelayanan kepada pasien. Namun demikian, meskipun mengalami peningkatan, capaian ini masih belum optimal sehingga tetap diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat ketidakkonsistenan pada beberapa kesempatan dalam

pelaksanaan identifikasi pasien. Oleh karena itu, diperlukan monitoring rutin, penguatan edukasi kepada petugas, supervisi yang berkesinambungan, serta pemberian umpan balik hasil observasi agar kepatuhan identifikasi pasien dapat terus meningkat dan tercapai secara konsisten sesuai target yang telah ditetapkan.

PLAN	Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 99.96% yang artinya belum mencapai standart, hal ini disebabkan petugas tidak selalu melakukan identifikasi dengan 2 identitas dan kurangnya kesadaran terhadap risiko keselamatan pasien.				
DO	1. Melaksanakan edukasi identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan 2. Memastikan pasien menggunakan gelang identitas sesuai standar 3. Melakukan observasi langsung kepatuhan identifikasi pasien sebelum tindakan, pemberian obat, dan pengambilan spesimen 4. Memberikan edukasi langsung bila ditemukan ketidaksesuaian				
STUDY	Capaian indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 99.96% yang artinya belum mencapai standart, hal ini disebabkan petugas tidak selalu melakukan identifikasi dengan 2 identitas dan kurangnya kesadaran terhadap risiko keselamatan pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Memberikan umpan balik hasil audit kepada unit terkait 2. Penguatan supervisi dan edukasi ulang pada unit dengan kepatuhan rendah 3. Penegakan disiplin sesuai kebijakan rumah sakit 4. Menjadikan identifikasi pasien sebagai budaya keselamatan pasien	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi



Gambar 3.4 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi

Analisis:

Pada bulan Januari 2026, capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ≤ 30 menit di RS Prima Husada Malang mencapai 100%, sehingga telah melampaui standar minimal yang ditetapkan sebesar 80%. Dari total 6 kasus operasi seksio sesarea emergensi, seluruh pasien memperoleh pelayanan dengan waktu respons sesuai standar, yaitu ≤ 30 menit. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan obstetri telah berjalan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas, Instalasi Kamar Operasi, serta dukungan manajemen rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan. Selain itu, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai turut berkontribusi terhadap tercapainya indikator ini. Hasil yang telah dicapai perlu dipertahankan secara konsisten sebagai upaya meminimalkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi serta menjamin keselamatan pasien secara optimal.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan



Gambar 3.5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan

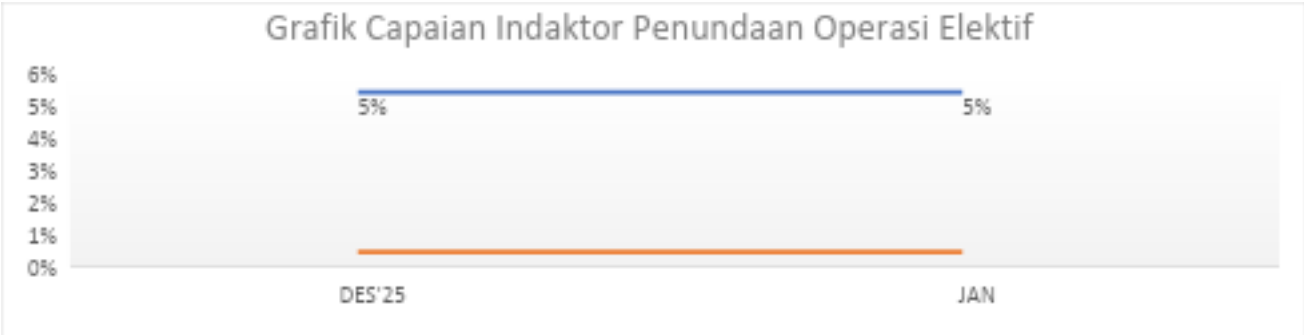
Analisis:

Pada bulan Januari 2026, capaian indikator waktu tunggu pelayanan rawat jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Malang mencapai 89,90%, mengalami penurunan sebesar 7,01% dibandingkan bulan Desember Tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan rawat jalan yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kunjungan pasien, keterbatasan sumber daya, maupun adanya kendala dalam alur pelayanan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar pasien telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar waktu tunggu yang ditetapkan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena waktu tunggu yang lebih lama dapat memengaruhi kepuasan pasien serta efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap proses pelayanan rawat jalan, termasuk optimalisasi alur pendaftaran, pemeriksaan, dan koordinasi antar unit pelayanan, serta monitoring secara berkala agar capaian indikator dapat kembali meningkat dan memenuhi target yang telah ditetapkan secara konsisten.

PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator mutu waktu tunggu rawat jalan di atas dapat diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 89.90%. Capaian belum maksimal 100% karena pendaftaran menumpuk pada jam jam tertentu dan masih ada keterlambatan kedatangan dokter. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah opyimalisasi sistem antrean dan pendaftaran online dan penyesuaian jam praktik dokter.				
DO	1. Melakukan sosialisasi alur pelayanan rawat jalan 2. Mengoptimalkan pendaftaran online dan sistem antrean 3. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter 4. Pengaturan jam pelayanan berdasarkan pola kunjungan pasien				
STUDY	Capaian waktu tunggu rawat jalan di bulan Januari yaitu 89.90%. Capaian belum maksimal 100% karena pendaftaran menumpuk pada jam jam tertentu dan masih ada keterlambatan kedatangan dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan	Tercapainya indikator waktu tunggu rawat jalan hingga 100%	1. Memberikan umpan balik kepada unit dan dokter terkait 2. Penyempurnaan alur pelayanan rawat jalan 3. Penyesuaian jadwal dan jumlah petugas secara berkelanjutan 4. 4. Monitoring rutin waktu tunggu sebagai indikator mutu prioritas	Manajemen	Satu Bulan
---	---	--	--	-----------	------------

6. Penundaan Operasi Elektif



Gambar 3.6 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

Analisis:

Pada bulan Januari 2026, capaian indikator penundaan operasi elektif di RS Prima Husada Malang tercatat sebesar 0%, sehingga telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu ≤5%. Tidak ditemukannya kejadian penundaan operasi elektif menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan operatif berlangsung secara efektif dengan koordinasi yang baik antar unit terkait. Pencapaian ini didukung oleh kerja sama yang optimal antara Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar Operasi, serta dukungan manajemen rumah sakit dalam menjaga kualitas pelayanan. Selain itu, perencanaan yang matang terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan peralatan, serta pengelolaan jadwal dan ruang operasi yang terorganisir dengan baik turut berperan dalam mencegah terjadinya penundaan. Hasil ini perlu dipertahankan secara konsisten sebagai upaya menjamin kelancaran pelayanan operatif, meningkatkan kepuasan pasien, dan menjaga keselamatan pasien.

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter



Gambar 3.7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

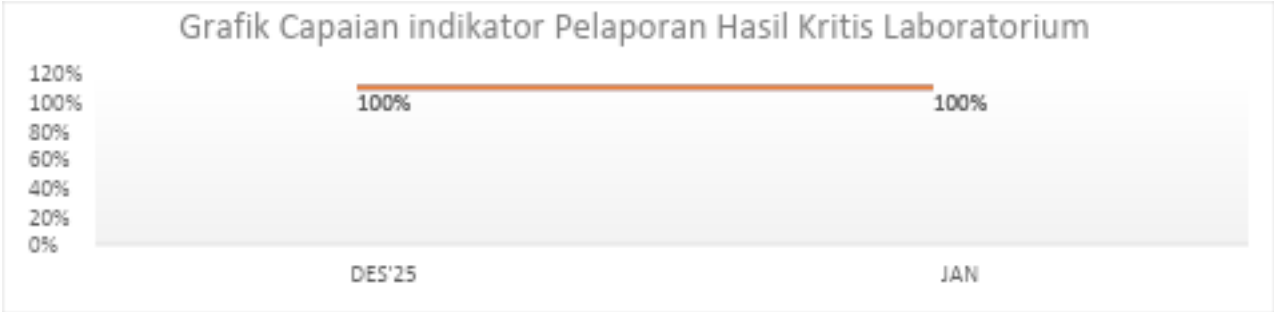
Analisis:

Pada bulan Januari, capaian indikator kepatuhan waktu visite dokter mencapai 66,75%, mengalami penurunan sebesar 1,06% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan konsistensi dalam ketepatan pelaksanaan visite dokter sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya beban pelayanan, keterbatasan waktu dokter, maupun kendala koordinasi antar unit pelayanan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan visite dokter masih perlu mendapat perhatian karena ketepatan waktu visite berperan penting dalam mendukung evaluasi kondisi pasien, pengambilan keputusan klinis, serta kelancaran pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap penyebab keterlambatan, penguatan koordinasi jadwal visite, monitoring berkala, serta upaya perbaikan berkelanjutan agar kepatuhan waktu visite dokter dapat meningkat dan memenuhi target yang telah ditetapkan secara konsisten.

PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite dokter dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari tahun 2026 yaitu 66.75%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang. Rencan aperbaikan yang akan dilakukan adalah penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.
DO	1. Penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati 2. Koordinasi perawat dengan DPJP terkait jadwal visite 3. Monitoring pelaksanaan visite oleh manajemen/unit terkait

STUDY	capaian indikator kepatuhan visite dokter di bulan Januari tahun 2026 yaitu 66.75%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang. Rencan aperibaikan yang akan dilakukan adalah penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	1. Memberikan umpan balik hasil monitoring kepada DPJP dan unit terkait 2. Penyesuaian jadwal dan sistem koordinasi visite 3. Penguatan komitmen DPJP terhadap standar pelayanan	Manajemen RS	Satu Bulan

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

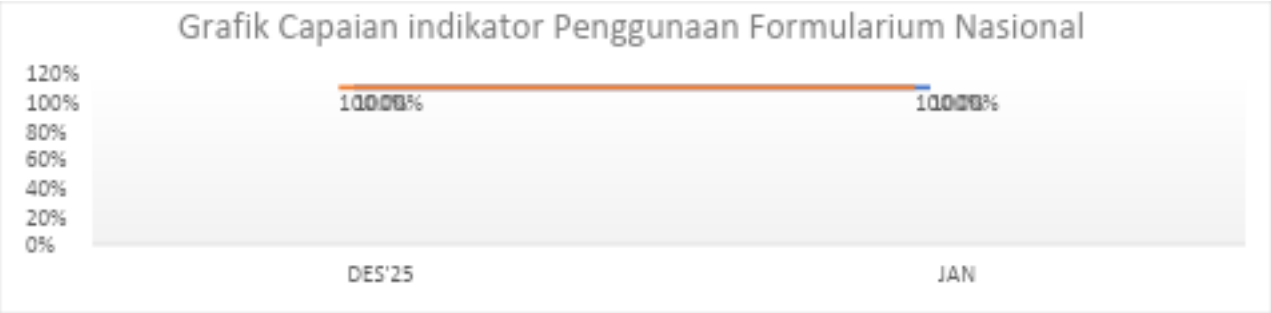


Gambar 3.8 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Analisis:

Pada bulan Januari, capaian indikator kepatuhan pelaporan hasil kritis laboratorium di RS Prima Husada Malang mencapai 100% dan berhasil dipertahankan dari bulan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pelaporan hasil kritis laboratorium telah dilaksanakan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan. Keberhasilan mempertahankan capaian ini mencerminkan adanya konsistensi petugas dalam melakukan pelaporan hasil kritis secara tepat waktu dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Kondisi ini juga menunjukkan efektivitas koordinasi yang baik antara unit laboratorium dengan tenaga medis terkait dalam menjamin keselamatan pasien. Hasil yang telah dicapai perlu terus dipertahankan melalui monitoring rutin, evaluasi berkala, serta penguatan kepatuhan petugas agar mutu pelayanan laboratorium tetap terjaga secara konsisten.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Gambar 3.9 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Analisis:

Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari tahun 2026 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Adanya payung hukum yang kuat, seperti Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional, memberikan landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan juga menjadi faktor yang membuat rumah sakit wajib mematuhi standart formularium nasional. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026.

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)



Gambar 3.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Analisis:

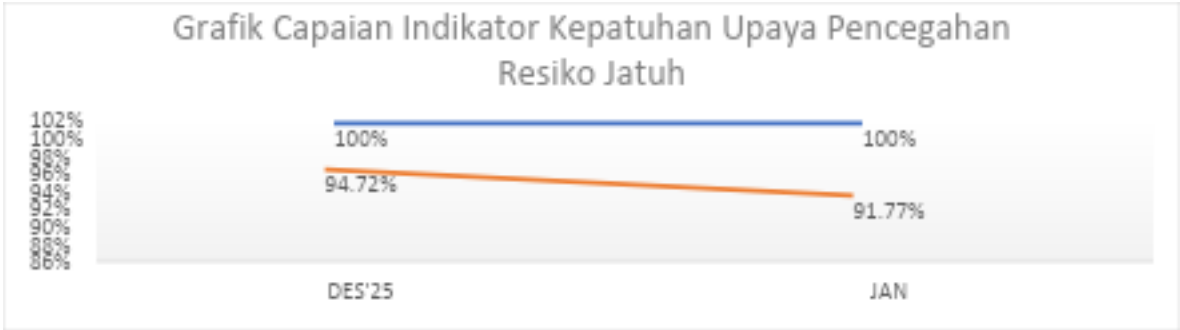
Pada bulan Januari, capaian kepatuhan *clinical pathway* (CP) di RS Prima Husada Malang mencapai **30,51%**, mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember tahun sebelumnya yang tercatat **100%**. Penurunan capaian ini perlu dianalisis secara hati-hati, karena perbedaan hasil tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan cakupan pengukuran data. Pada bulan Desember, pengukuran hanya dilakukan pada Unit Maternitas sehingga capaian yang diperoleh belum merepresentasikan keseluruhan unit pelayanan yang seharusnya menjadi objek penilaian. Sementara itu, pada bulan Januari pengukuran telah dilakukan dengan cakupan yang lebih luas sesuai ketentuan, sehingga hasil yang diperoleh memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap tingkat kepatuhan *clinical pathway* di rumah sakit secara keseluruhan.

Capaian ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kepatuhan dalam implementasi *clinical pathway* pada seluruh unit pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CP, serta standarisasi metode pengumpulan data agar hasil pengukuran lebih akurat, konsisten, dan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

PLAN	Berdasarkan grafik capaian kepatuhan terhadap alur klinis diatas, dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari yaitu 31.91%. Hal ini disebabkan karena kepatuhan tenaga medis dalam menerapkan Clinical pathway belum optimal, dokumen CP belum terintegrasi dengan rekam medis, monitoring dan evaluasi CP belum rutin. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi dan refresh clinical pathway kepada DPJP dan PPA dan Standarisasi penggunaan CP serta audit kepatuhan CP secara berkala.				
DO	1. Melaksanakan edukasi penggunaan CP kepada DPJP dan tim PPA 2. Menerapkan CP pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan 3. Melakukan pengisian CP secara lengkap dan tepat waktu 4. Supervisi penerapan CP oleh komite medis / PMKP				
STUDY	Capaian di bulan Januari yaitu 31.91%. Hal ini disebabkan karena kepatuhan tenaga medis dalam menerapkan Clinical pathway belum optimal, dokumen CP belum terintegrasi dengan rekam medis, monitoring dan evaluasi CP belum rutin. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi dan refresh clinical pathway kepada DPJP dan PPA dan Standarisasi penggunaan CP serta audit kepatuhan CP secara berkala.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis	Indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standrt	1. Melaksanakan edukasi penggunaan CP kepada DPJP dan tim PPA 2. Menerapkan CP pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan 3. Melakukan pengisian CP secara lengkap dan tepat waktu	Manajemen RS	Satu Bulan

			4. Supervisi penerapan CP oleh komite medis / PMKP		
--	--	--	--	--	--

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Gambar 3.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Analisis:

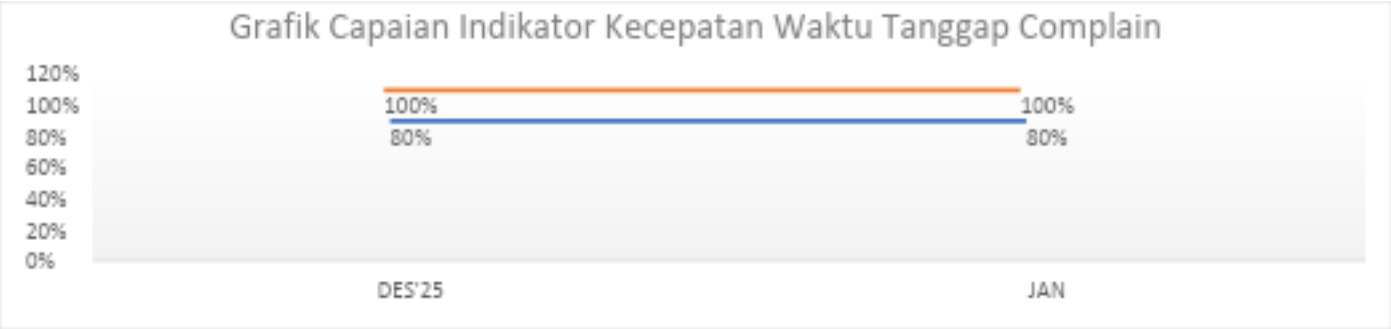
Pada bulan Januari Tahun 2026, capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh di RS Prima Husada Malang sebesar **91,77%**, mengalami penurunan sebesar **2,95%** dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian ini belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pencegahan risiko pasien jatuh masih belum optimal. Penurunan capaian ini dapat disebabkan oleh belum konsistennya kepatuhan petugas dalam melaksanakan intervensi pencegahan risiko jatuh sesuai prosedur, belum optimalnya pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga terkait pencegahan risiko jatuh, serta monitoring dan dokumentasi yang belum dilakukan secara lengkap dan konsisten.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena upaya pencegahan risiko jatuh merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan pasien selama menjalani perawatan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa sosialisasi ulang terkait SOP pencegahan risiko jatuh kepada seluruh petugas, pelaksanaan audit kepatuhan secara rutin, peningkatan supervisi oleh kepala unit, serta penguatan evaluasi dokumentasi agar implementasi upaya pencegahan risiko pasien jatuh dapat berjalan lebih optimal dan capaian indikator dapat meningkat sesuai standar yang telah ditetapkan.

PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 91.77%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan
------	---

	keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.				
DO	1. Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala 2. Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) 3. Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko 4. Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh				
STUDY	Capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Januari tahun 2026 yaitu 91.77%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	1. Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala 2. Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) 3. Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko 4. Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh	Perawat instalasi rawat inap	- Satu Bulan

12. Kecepatan waktu tanggap komplain



Gambar 3.12 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Analisis:

Pada bulan Januari 2026, capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 100% dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian ini juga berhasil dipertahankan dari bulan sebelumnya. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa melalui telepon, WA dan formulir online. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien

Analisis:

Pada bulan Januari 2026, capaian indikator kepuasan pasien di RS Prima Husada Malang sebesar 99,70%, mengalami peningkatan sebesar 6,9% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan mutu pelayanan yang dirasakan oleh pasien, baik dari aspek ketepatan pelayanan, sikap petugas, komunikasi, maupun kenyamanan selama menerima pelayanan di rumah sakit. Capaian yang sangat tinggi ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilakukan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap persepsi pasien terhadap pelayanan rumah sakit.

Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui evaluasi berkala terhadap umpan balik pasien, penguatan budaya pelayanan prima, peningkatan kompetensi petugas, serta perbaikan berkelanjutan pada aspek pelayanan yang masih memerlukan perhatian. Dengan demikian, tingkat kepuasan pasien dapat terjaga secara konsisten dan mendukung peningkatan mutu pelayanan di RS Prima Husada Malang.

. PLAN	Berdasarkan grafik capaian indikator kepuasan pasien dapat diketahui capaian di bulan Januari tahun 2026 yaitu 99.7%. Capaian telah mencapai standart walaupun belum maksimal 100%. Masih di dapatkan komplain terkait komunikasi petugas yang tidak efektif serta kenyamanan yang kurang optimal. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah evaluasi hasil survey dan kepuasan, peningkatan komunikasi efektif dan pelayanan prima.				
DO	1. Memberikan edukasi pelayanan prima kepada petugas 2. Menindaklanjuti keluhan dan saran pasien 3. Perbaikan layanan berdasarkan masukan pasien				
STUDY	Capaian indikator kepuasan pasien dapat diketahui capaian di bulan Januari tahun 2026 yaitu 99.7%. Capaian telah mencapai standart walaupun belum maksimal 100%. Masih di dapatkan komplain terkait komunikasi petugas yang tidak efektif serta kenyamanan yang kurang optimal. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah evaluasi hasil survey dan kepuasan, peningkatan komunikasi efektif dan pelayanan prima.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian Indikator Kepuasan Pasien	Meningkatkan capaian Indikator Kepuasan Pasien	Peningkatan capaian indikator kepuasan pasien	1. Memberikan edukasi pelayanan prima kepada petugas 2. Menindaklanjuti keluhan dan saran pasien 3. Perbaikan layanan berdasarkan masukan pasien	Seluruh layanan	- Satu Bulan

3.2 Pemantauan Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

Tabel 3.10 Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

[illegible]

3.4 Tujuan Strategis

Tabel 3.12 Capaian Indikator Mutu Tujuan Strategis

Tabel 3.12 Capaian Indikator Mutu Tujuan Strategis

[illegible]

3.5 Perbaikan Sistem

Tabel 3.13 Capaian Indikator Mutu Perbaikan Sistem

Tabel 3.13 Capaian Indikator Mutu Perbaikan Sistem

[illegible]

BAB IV

HASIL KEGIATAN MUTU PRIORITAS UNIT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

110	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien dengan resiko HIV/AIDS	PROGNAS HIV														100%
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Keterangan:

Data capaian indikator mutu pada bulan Januari yang belum tersedia disebabkan pada bulan Januari masih berlangsung proses finalisasi indikator mutu unit dan indikator prioritas, meskipun penetapannya telah tercantum dalam Surat Keputusan pada bulan Januari. Selain itu, masih dilakukan tahapan sosialisasi kepada unit terkait, penyamaan pemahaman terhadap definisi operasional indikator, serta penyesuaian mekanisme pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data.

Kondisi ini menyebabkan proses monitoring belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga belum diperoleh data capaian yang representatif. Mulai periode berikutnya, setelah seluruh indikator terkonfirmasi dan mekanisme pelaporan berjalan lebih terstruktur, pengukuran diharapkan dapat dilakukan secara konsisten sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut perbaikan mutu pelayanan.

BAB III
INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

Laporan IKP Bulan Januari

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		JENIS IKP	KRONOLOGI	RENCANA TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
1	6 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulakn risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu “lantai basah” - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
2	8 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulakn risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu “lantai basah” - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan

3	14 Januari		2C	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu “lantai basah” - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
4	19 Januari	dr. Yuniar Ardi San	IGD	KTC	Anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak sesuai	Penguatan supervisi dokter IGD
5	19 Januari	dr. Naufal, Laras	Farmasi	KTC	Kesalahan input e-resep	
6	19 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu “lantai basah” - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
7	26 Januari	Laras, Noviati, Ria	Farmasi	KTC	Kesalahan pemberian obat	- Refresh SOP e-resep - Double check sebelum validasi resep

						- Edukasi keselamatan obat
8	28 Januari	Iqbal	IRNA 234A	KPC	Tidak melakukan advice dokter sesuai jam yang di advicekan	- Penguatan komunikasi DPJP & perawat - Monitoring pelaksanaan advice - Edukasi patient safety

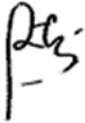
BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Komite Mutu rumah sakit di Rumah Sakit Prima Husada Malang Bulan Januari Tahun 2026. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dikerjakan saat ini, tentunya upaya yang berkesinambungan dan tidak mengenal lelah terus dilakukan sehingga tercapai hasil tertinggi bagi semua komponen pemberi dan pengguna layanan rumah sakit.

Malang, 06 Februari 2026

Ketua Komite MUTU



dr. Ari Putriani, Sp.PK

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

